RÉSIDANAT / SP 2026

Cas cliniques Hépato-gastro-entérologie & Chirurgie viscérale

Recueil des cas cliniques et des QCM figurant dans les cours, avec leurs corrigés — suivi d'une série de cas cliniques prévisibles.

Compilé à partir de 13 cours : Colite aiguë grave · Hémorragie digestive basse · Ictère · Pancréatite aiguë · Hépatites B & C · Hépatites virales (virologie) · Infarctus entéro-mésentérique · Cancer du côlon · Lithiase biliaire · Occlusions intestinales aiguës · Hémorragies digestives liées et non à l'HTP · Complications de la cirrhose · Maladie cœliaque.

Sommaire

Partie I — Cas cliniques extraits des cours

1 Colite aiguë grave — *1 cas clinique* p. 3

2 CAT devant une hémorragie digestive — *3 cas cliniques* p. 5

3 CAT devant un ictère — *3 cas cliniques* p. 9

4 Pancréatite aiguë : CAT — *1 dossier clinique* p. 15

5 Hépatites B & C : CAT diagnostique et thérapeutique — *2 cas cliniques* p. 19

6 Ischémie mésentérique aiguë / infarctus entéro-mésentérique — *5 QCM + 1 mini-cas* p. 23

7 Cancer du côlon — *1 cas clinique en 8 questions* p. 26

8 Lithiase biliaire et ses complications — *2 exemples cliniques* p. 31

9 Cours ne comportant pas de cas clinique p. 33

Partie II — Cas cliniques probables (prévisions d'examen)

10 Comment ces cours construisent leurs cas — mode d'emploi p. 34

11 Points chauds et cas prévisibles, cours par cours (les 13 cours) p. 34

12 Les réflexes transversaux à réciter le jour de l'examen p. 49

Comment lire ce document

■ **Corrigé du cours** — réponse effectivement donnée / surlignée dans le diaporama, reproduite fidèlement.

■ **Réponse rédigée d'après le cours** — le diaporama ne donnait pas la réponse ; elle a été rédigée à partir du contenu du même cours.

Les énoncés sont reproduits tels quels (y compris les abréviations et les valeurs du cours). Les seules retouches portent sur les fautes de frappe manifestes issues de la numérisation.

2. CAT devant une hémorragie digestive basse

Source : diaporama « CAT devant une Hémorragie Digestive Basse » — trois cas cliniques répartis dans le cours.

Cas clinique 1 — Mme Louiza, 45 ans

> Mme Louiza, 45 ans, consulte pour la présence de quelques gouttes de sang rouge vif dans ses selles depuis 3 jours.
>
> **Anamnèse :** selles normales, sans diarrhée ni douleur abdominale, proctalgies. Pas de vertiges, pas de malaise. Pas d'ATCD particuliers, pas d'antiagrégants, pas d'AINS.
>
> **Examen clinique :** bonne coloration cutanéo-muqueuse ; constantes normales FC : 72 b/mn ; TA = 115/60 ; abdomen souple.

Question 1 — Que faites-vous ?

A. Faire une rectoscopie en urgence

B. Interrogatoire + examen proctologique

C. Faire une coloscopie en urgence

D. NFS en urgence ?

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponse B** — Interrogatoire + examen proctologique.
>
> *Rectorragies minimes, patiente stable, sans signe de gravité : rien d'urgent. Le cours détaille l'enquête étiologique : âge, ATCD de MH / MICI / néoplasie ou polypose digestive personnelle ou familiale, cardiopathie thrombogène, radiothérapie, prise de température rectale, prise d'AINS / anticoagulants / AAP, type de l'hémorragie, signes associés (troubles du transit, AEG) ; puis examen méthodique et complet, examen digestif (masse abdominale, HTP, ascite, HPM) et surtout **examen proctologique** (marge anale : fissure, hémorroïdes ; TR : masse intra-rectale ; anuscopie et rectoscopie).*

Cas clinique 2 — Mr Djamel, 62 ans

> Mr Djamel, 62 ans, arrive pour des selles noires et pâteuses depuis 24 h, avec fatigue et vertiges.
>
> **ATCD :** HTA, aspirine 100 mg/j (75 mg/j sur la diapositive suivante).
>
> **Constantes :** TA 95/60, FC 112/min. **Examen :** TR = selles noires goudronneuses.

Question 1 — Quelle est votre conduite immédiate ?

A. Perfusion IV, oxygène, bilan sanguin, monitorage

B. Adresser le patient au gastroentérologue de garde

C. Demander une coloscopie en urgence

D. Arrêter l'aspirine

CORRIGÉ DU COURS

Réponse A — Perfusion IV, oxygène, bilan sanguin, monitorage.

Patient en instabilité hémodynamique (TA 95/60, FC 112) : la réanimation précède toute exploration. Le cours rappelle la surveillance clinique rapprochée : FC, PA, état de conscience, diurèse, nombre d'unités transfusées et de solutés perfusés, éventuellement mesure de la PVC.

Le patient est hospitalisé aux urgences et mis en condition. **Bilan sanguin :** Hb 6,4 g/dl ; plaquettes 250 000/mm³ ; GB 6 800/mm³ ; urée sanguine 0,42 g/l, créatininémie 10 mg/l, ionogramme correct ; TP 85 %.

Question — À quel taux d'hémoglobine transfusez-vous ?

CORRIGÉ DU COURS

Transfusion si :

- Hb < 7 g/dl chez un patient stable ;
- Hb < 9 g/dl si comorbidités, choc, signes cliniques sévères ;
- éviter la sur-transfusion.

Le patient reçoit 2 culots globulaires, son état hémodynamique est stable, l'Hb de contrôle est à 8,1 g/dl.

Question 2 — Quel examen est indiqué en première intention ?

A. Coloscopie en urgence

B. Fibroscopie digestive haute urgente

C. Angio-IRM

D. Angioscanner abdomino-pelvien

CORRIGÉ DU COURS

Réponse B — Fibroscopie digestive haute urgente.

*Devant un méléna avec retentissement hémodynamique, il faut d'abord **éliminer une hémorragie digestive haute** : 10 à 15 % des patients se présentant pour une HDB ont en réalité une cause haute.*

Question 3 — La gastroscopie ne retrouve pas l'origine du saignement, que faites-vous ?

A. TDM TAP

B. Angioscanner abdomino-pelvien

C. Coloscopie totale

D. Rectoscopie

CORRIGÉ DU COURS

Réponse C — Coloscopie totale.

*Le patient est désormais **stable** : la coloscopie après préparation colique (4 à 6 l de PEG en 3 à 4 h, éventuellement par SNG) est l'examen de référence, diagnostique et thérapeutique. La responsabilité d'une lésion colique est certaine s'il existe un saignement actif ou des signes d'hémorragie récente au sein de la lésion (caillot adhérent, vaisseau visible). L'angioscanner est réservé au patient **instable**.*

Évolution : la coloscopie retrouve des diverticules dans le côlon gauche → hémostase endoscopique → pas de récidive.

Cas clinique 3 — Mr Bachir, 71 ans

Mr Bachir, 71 ans, présente depuis ce matin 4 selles rouges abondantes avec caillots.
ATCD : fibrillation auriculaire sous anticoagulant oral direct.
Constantes : TA 80/50, FC 130/min, pâleur, sueurs. **TR :** sang rouge franc.

Question 1 — Quelle est votre conduite en urgence ?

A. Stabilisation hémodynamique (O_2, 2 voies veineuses, remplissage, transfusion, arrêt anticoagulant)
B. Examen proctologique en premier
C. Coloscopie immédiate sans préparation
D. Gastroscopie

CORRIGÉ DU COURS

Réponse A — Stabilisation hémodynamique.

Antagonisation selon l'anticoagulant : AVK → vitamine K IV et/ou PPSB (à défaut PFC) ; AOD → antidotes (idarucizumab pour le dabigatran ; andexanet ou PPSB pour les anti-facteur Xa), en coordination avec l'hémostasien. Reprise de l'anticoagulation le plus rapidement possible dans les 7 jours si l'indication persiste — préférablement dans les 72 h, par héparine, chez les patients à haut risque thrombotique.

Question 2 — Après remplissage + transfusion, le patient reste instable. Quel examen réaliser maintenant ?

A. Gastroscopie
B. Angio-scanner abdomino-pelvien
C. Coloscopie
D. IRM colique

CORRIGÉ DU COURS

Réponse B — Angio-scanner abdomino-pelvien.

« En cas d'HDB grave avec patient instable (shock index > 1) malgré la réanimation, l'angioscanner suivi éventuellement d'une embolisation artérielle doit être réalisé en urgence, en première intention. »

Question 3 — L'angio-scanner montre un saignement actif au côlon droit. Quelle prise en charge thérapeutique ?

A. Coloscopie + pose de clips

B. Coloscopie + coagulation au plasma Argon

C. Embolisation artérielle sélective

D. Chirurgie d'emblée

CORRIGÉ DU COURS

Réponse C — Embolisation artérielle sélective.

L'angiographie est réalisée en cas de positivité de l'angio-TDM, avec embolisation radiologique dans les 60 minutes. La chirurgie est discutée pour les patients en échec de l'endoscopie et/ou de la radiologie.

Évolution : après embolisation, arrêt du saignement. Patient stable.

Conclusion du cours (à réciter) : l'HDB cesse spontanément dans **80 %** des cas mais la récidive est fréquente. Les causes les plus fréquentes sont les **diverticules**, la pathologie ano-rectale et les colites. Une gastroscopie en phase aiguë est réalisée dès que possible chez tout patient présentant une HDB avec instabilité hémodynamique. La coloscopie après préparation est l'examen de référence, son rendement est meilleur dans les 24 premières heures. Patient instable malgré la réanimation → angioscanner ± embolisation en première intention.

3. CAT devant un ictère

Source : diaporama « CAT Ictère » — trois cas cliniques (le même fichier PDF contient également, à sa suite, les cours de virologie et d'hépatites B & C, traités plus loin).

Cas clinique (1) — Patient de 75 ans

> Patient âgé de 75 ans, admis pour l'exploration d'un :
> – ictère cutanéo-muqueux franc progressif ;
> – prurit ;
> – douleurs épigastriques intenses par poussées à irradiation postérieure ;
> – amaigrissement de 10 kg en 4 mois.
>
> L'examen général montre des signes de DHA, aucune anomalie neurologique.

Question 1 — Que faut-il rechercher lors de l'examen de l'abdomen ?

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> Une **vésicule biliaire palpable**.
>
> *Grosse vésicule palpable + ictère nu et progressif = obstacle sous-cystique tumoral (loi de Courvoisier-Terrier).*

Question 2 — Quels examens demandez-vous en premier lieu ?

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Examens biologiques :** FNS ; bilan hépatique ; glycémie veineuse ; bilan rénal ; ionogramme sanguin.
> **Morphologiques :** ASP ; échographie abdominale.

> **Résultats.** Biologie : bilirubine T 84 mg/l, BC 65 mg/l ; le reste est normal. ASP : aérocolie.
>
> Échographie abdominale : dilatation de la voie biliaire principale ; le foie est normal ; le pancréas non vu, gêné par les gaz.

Question 3 — Devant ces données clinico-biologiques et morphologiques, quels diagnostics évoquez-vous en priorité ?

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> - Cancer de la tête du pancréas
> - Ampullome vatérien
> - Pancréatite chronique
> - Cholangiocarcinome
> - Compression extrinsèque (cancer de voisinage)
> - Lithiase de la voie biliaire principale

La suite du cours enchaîne sur la TDM abdominale.

Cas clinique (2) — Homme de 35 ans

Homme, 35 ans, sans ATCD particuliers, fumeur actif.

Se présente en consultation pour un ictère cutanéo-muqueux apparu il y a 4–5 jours, nausées, fatigue. L'examen clinique est sans anomalie hormis l'ictère.

Il apporte un bilan réalisé il y a deux jours :

– ASAT : 234 UI, ALAT : 380 UI
– PAL : 340 UI, GGT : 104 UI
– Bil T : 57 mg/l, Bil C : 51 mg/l
– Urée : 0,35 g/l, créatinine : 10 mg/l

Question 1 — Quelles sont les données à rechercher à l'interrogatoire pour éliminer une éventuelle urgence ?

a. Une prise médicamenteuse avant l'apparition de l'ictère
b. Une douleur de l'HCD suivie par l'installation d'une fièvre
c. Des signes d'encéphalopathie hépatique
d. Une prise d'alcool
e. Un syndrome pseudo-grippal avant l'apparition de l'ictère

CORRIGÉ DU COURS

Réponses b et c. Les deux urgences à éliminer devant un ictère sont l'**angiocholite** (douleur de l'HCD → fièvre → ictère) et l'**insuffisance hépatique aiguë grave** (encéphalopathie hépatique).

Question 2 — Quels autres examens paracliniques faisant partie du bilan de 1re intention manquent à cette évaluation initiale ?

a. NFS
b. Taux de réticulocytes
c. TP
d. Sérologies virales A, B et C
e. TDM abdomino-pelvienne

RÉPONSE RÉDIGÉE D'APRÈS LE COURS

a, c et d — et il faut y ajouter l'**échographie abdominale**, systématique devant tout ictère.

*Le diaporama ne comportait pas de diapositive-réponse pour cette question. Justification tirée du même cours : le bilan de première intention devant un ictère associe FNS, bilan hépatique complet, **TP** (recherche d'une insuffisance hépatocellulaire = critère de gravité), sérologies virales (A, B, C ± E) et échographie abdominale pour trancher entre cholestase intra- et extra-hépatique. Les réticulocytes n'ont d'intérêt que devant un ictère à bilirubine **libre** (hémolyse), ce qui n'est pas le cas ici (BC 51/57). La TDM n'est pas un examen de première intention.*

Question 3 — Les résultats du bilan biologique ainsi que de l'échographie abdomino-pelvienne sont compatibles avec les conclusions suivantes :

a. Ictère à bilirubine libre

b. Ictère à bilirubine conjuguée par atteinte intra-hépatique

c. Ictère à bilirubine conjuguée par atteinte extra-hépatique

d. Syndrome de cytolyse

e. Syndrome de cholestase

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponses b, d et e.** Bilirubine conjuguée prédominante (51/57), cytolyse marquée (ALAT > ASAT, > 5 N) et cholestase biologique (PAL, GGT) sans dilatation des voies biliaires à l'échographie → cholestase **intra-hépatique**.

Question 4 — Quel(s) est (sont) le(s) bilan(s) à visée étiologique que vous demanderiez dans ce cas ?

a. Électrophorèse de l'Hb

b. Test de Coombs

c. Sérologies virales A, B, C

d. Test génétique codant pour l'UGT1A1

e. TDM abdomino-pelvienne

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponse c** — Sérologies virales A, B, C. Les items a, b et d explorent un ictère à bilirubine **libre** (hémolyse, maladie de Gilbert), écarté par la question précédente.

Question 5 — Le patient et son entourage signalent plusieurs cas d'ictère dans le voisinage au cours des deux dernières semaines. Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Hémolyse aiguë

b. Tuberculose hépatique

c. Hépatite virale B

d. Hépatite virale A

e. Maladie de Gilbert

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponse d** — Hépatite virale A : transmission féco-orale (entérale/hydrique), d'où les cas groupés dans le voisinage.

Question 6 — Le bilan confirme qu'il s'agit bien d'une hépatite aiguë A (IgM anti-VHA +), le malade est stable cliniquement, son bilan hépatique actuel donne : ASAT et ALAT > 20 N, PAL : 340 UI, TP : 32 %, bilan rénal normal. Quelle est la situation actuelle du patient ?

a. Cirrhose hépatique

b. Hépatite fulminante

c. Hépatite subfulminante

d. Hépatite sévère

e. Aucune de ces situations

CORRIGÉ DU COURS

Réponse d — Hépatite **sévère** : TP < 50 % sans encéphalopathie hépatique. Le qualificatif fulminante (EH < 2 semaines après l'ictère) ou subfulminante (EH entre 2 semaines et 3 mois) suppose la présence d'une encéphalopathie, absente ici puisque le malade est « stable cliniquement ».

Cas clinique (3) — Femme de 42 ans

Femme, 42 ans, hypertendue, sous CO (contraception orale).

Douleur épigastrique, intense depuis 7 h, nausées, vomissements.

Examen clinique : ictère conjonctival ; abdomen sensible mais pas de défense, pas d'organomégalie ; TA 120/80, pouls 95/min ; T° 37,8 ; taille 160 cm, poids 82 kg.

Question 1 — Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?

1. Pancréatite aiguë
2. Embolie pulmonaire
3. Colique hépatique
4. Dissection aortique
5. Infarctus du myocarde

RÉPONSE RÉDIGÉE D'APRÈS LE COURS

Les deux diagnostics à évoquer en priorité sont la **colique hépatique / pathologie biliaire lithiasique (3)** et la **pancréatite aiguë (1)** : douleur épigastrique brutale et intense, ictère, fébricule, terrain (femme, surpoids IMC ≈ 32, contraception orale). Les items 4 et 5 (et accessoirement 2) sont les diagnostics « à ne pas manquer » que le cours élimine immédiatement à la diapositive suivante par un **ECG normal** et une **lipasémie normale**.

Le surlignage de la diapositive-réponse est illisible sur le document numérisé ; la réponse ci-dessus est reconstituée à partir de la suite du cas (ECG, lipasémie, puis échographie) et du diagnostic final retenu.

ECG normal.

Biologie : GB 12 350/mm³, Hb 13 g, PL 340 000/mm³ ; lipasémie 51 UI ; Bil T 28 mg/l, Bil C 21 mg/l, PAL 260 UI, GGT 80 UI, TP 90 %, TGO 40 UI, TGP 50 UI ; urée 0,34 g, créatinine 9 mg/l.

Question 2 — Interprétez le bilan biologique.

1. Insuffisance hépatocellulaire
2. **Syndrome de cytolyse**

3. Syndrome de cholestase

4. Lipasémie en faveur d'une PA

5. Infarctus du myocarde

CORRIGÉ DU COURS

Réponses 2 et 3 — discret syndrome de cytolyse et syndrome de cholestase (ictère à bilirubine conjuguée, PAL et GGT élevées). Le TP à 90 % élimine l'insuffisance hépatocellulaire ; la lipasémie à 51 UI (normale) écarte la pancréatite aiguë.

Question 3 — Vous décidez de faire une échographie abdominale, quels signes recherchez-vous ?

a. Un épaississement de la paroi vésiculaire

b. Une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques

c. Une lithiase vésiculaire

d. Une lithiase de la VBP

e. Un foie de cirrhose

CORRIGÉ DU COURS

Réponses b, c et d.

L'échographie montre en effet une vésicule macro- et microlithiasique, à paroi épaissie ; la VBP mesure 13 mm, aucun obstacle n'est identifié en son sein ; quelques ADP hilaires hépatiques ; par ailleurs des gaz gênent l'exploration du pancréas.

Question 4 — Quel examen non invasif faut-il réaliser à présent ?

a. Une TDM TAP

b. Des sérologies virales

c. Une CPRE

d. Une cholangio-IRM

e. Une échoendoscopie bilio-pancréatique

CORRIGÉ DU COURS

Réponse d — Cholangio-IRM : examen **non invasif** de référence pour la VBP. La CPRE est un geste thérapeutique (invasif) et l'échoendoscopie est semi-invasive.

Question 5 — Quels éléments de cette observation vous font suspecter une étiologie lithiasique ?

a. La prise de contraceptifs oraux

b. Le syndrome métabolique

c. La normalité de la lipasémie

d. La cytolyse

e. Le caractère aigu et récent des signes

CORRIGÉ DU COURS

Réponses a, b et d — facteurs de risque lithogènes (œstroprogestatifs, surpoids/syndrome métabolique) et pic précoce et fugace de cytolyse, très évocateur d'une migration lithiasique.

Diagnostic final retenu par le cours (cholangio-IRM) : angiocholite + cholécystite aiguës lithiasiques.

4. Pancréatite aiguë : conduite à tenir

Source : diaporama « Pancréatite Aiguë — CAT », rubrique **DOSSIER CLINIQUE** en fin de cours.

Dossier clinique — Femme de 52 ans

> Madame, 52 ans, obèse, diabétique sous hypoglycémiants oraux, se présente aux urgences pour une douleur épigastrique intense survenue il y a une heure, irradiant en barre, transfixiante et accompagnée de vomissements bilieux.
>
> L'examen clinique retrouve une patiente pâle, agitée, en position penchée en avant. FC : 110 bat/mn, FR : 22 cycles/mn, TA : 120/95 mmHg, T : 37,5 °C.
>
> **Bilan biologique :** GB 13 800 élts/mm³, Hb 11 g/dl, TP 30 %, urée et créatinine normales, lipasémie 710 UI (N ≤ 63).
>
> Le diagnostic d'une **pancréatite aiguë** est retenu.

Question 1 — Selon vous cette pancréatite est classée (cochez une réponse juste) :

A. PA bénigne

B. Fulminante

C. Gravité intermédiaire

D. Grave

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponse D** — pancréatite aiguë **grave**.

Question 2 — Pour évaluer la gravité de la pancréatite aiguë (cochez les réponses justes) :

1. Utilisez-vous des scores prédictifs ? Ranson, Apache, Imrie ?
2. Faites-vous un monitoring de la lipasémie ?
3. **Faites-vous un monitoring de la CRP ?**
4. Utilisez-vous le score de Balthazar ?
5. **Recherchez-vous un SIRS ?**
6. **Demandez-vous toujours un scanner pour évaluer la gravité ? Si oui, quand : H48 ? H72 ? H96 ?**

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponses 3 – 5 – 6 (72 h – 96 h).** Monitoring de la CRP, recherche d'un SIRS, et scanner de gravité réalisé entre la 72e et la 96e heure.
>
> *Corollaires : le taux de lipase n'a **aucune** valeur pronostique (il ne sert qu'au diagnostic positif) et son monitoring est inutile ; les scores de Ranson/Imrie/Apache sont lourds et différés ; le score de Balthazar (TDM) n'a de sens que si le scanner est fait au bon moment (trop précoce, il sous-estime la nécrose).*

Question 3 — Nous avons utilisé le SIRS comme score de gravité de la PA. Ce score est de (cochez la réponse juste) :

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

CORRIGÉ DU COURS

Réponse D — 3 critères.

- Pouls 110/mn (> 90) ✔
- GB 13 800/mm³ (> 12 000) ✔
- Fréquence respiratoire 22/mn (> 20) ✔
- Température 37,5 °C (ni < 36 ni > 38) ✘

Rappel du cours — critères du SIRS : température < 36 °C ou > 38 °C ; fréquence cardiaque > 90/mn ; fréquence respiratoire > 20/mn ou PCO_2 < 32 mmHg ; globules blancs < 4 000 ou > 12 000/mm³.

Question 4 — Pour établir un diagnostic étiologique, le bilan initial doit inclure (cochez la réponse juste) :

1. Une échographie abdominale
2. TDM abdominale
3. Dosage des ASAT
4. Dosage des ALAT
5. Le TP

A (1, 2) / B (1, 3) / C (2, 3) / **D (1, 4)** / E (3, 4, 5)

CORRIGÉ DU COURS

Réponse D (1, 4) — échographie abdominale + dosage des ALAT.

*La diapositive-réponse ne conserve que « 1- Une échographie abdominale » et « 4- Dosage des ALAT ». Ce sont les deux éléments de la recherche d'une origine **biliaire** : l'échographie (lithiase vésiculaire, dilatation de la VBP) et l'élévation précoce des ALAT (> 3 N dans les 48 premières heures = argument fort pour une migration lithiasique). La TDM n'est pas un examen étiologique de première intention.*

Question 5 — La prise en charge initiale consiste ; cochez les réponses fausses :

A. Hospitalisation

B. Proposer des antalgiques par palier selon la réponse

C. Mettre une ATB prophylactique

D. Arrêt temporaire de l'alimentation orale

E. Opérer en urgence les nécroses PK

F. Surveillance sur les plans clinique et biologique

CORRIGÉ DU COURS

Réponses fausses : C et E. Pas d'antibioprophylaxie systématique dans la PA (l'antibiothérapie n'est indiquée qu'en cas d'infection documentée de la nécrose) ; pas de chirurgie en urgence des nécroses pancréatiques (prise en charge différée, « step-up approach » : drainage percutané/endoscopique d'abord, nécrosectomie retardée au-delà de la 4e semaine).

Évolution. Après 36 heures d'hospitalisation, on assiste à une disparition de la douleur et des vomissements, et à l'apparition d'un ictère cutanéo-muqueux. Le bilan hépatique objective une bilirubine totale à 95 mg/l et une bilirubine libre à 15 mg/l. Une échographie abdominale retrouve une vésicule biliaire à paroi fine, microlithiasique, et une dilatation de la voie biliaire principale à 13 mm sans visualisation d'obstacle.



Question 6 — Le bilan morphologique pour explorer la voie biliaire principale comprend (cochez la réponse juste) :

A. Une radiographie de l'abdomen sans préparation

B. Une autre échographie

C. Une TDM

D. Une cholangio-IRM

E. Aucune de ces réponses

CORRIGÉ DU COURS

Réponse D — Une cholangio-IRM.

Question 7 — L'ictère présenté par la patiente est dû à (cochez la réponse juste) :

A. Un cancer de la tête du pancréas

B. Un cholangiocarcinome

C. Une migration d'un calcul dans la VBP

D. Un ampullome vatérien

E. Une sténose inflammatoire de la VBP

CORRIGÉ DU COURS

Réponse C — migration d'un calcul dans la VBP (ictère à bilirubine **conjuguée** : BT 95 mg/l dont seulement 15 mg/l de libre, sur une vésicule microlithiasique avec VBP à 13 mm).

Question 8 — Quelle prise en charge thérapeutique ?

A. CPRE avec SE puis cholécystectomie laparoscopique

B. Prothèse biliaire, résection duodéno-pancréatique

C. Résection VBP

D. TRT par AINS

E. CPRE + SE

CORRIGÉ DU COURS

Réponse A — CPRE avec sphinctérotomie endoscopique (désobstruction de la VBP) **puis** cholécystectomie par voie laparoscopique, pour traiter la cause et prévenir la récidive. La réponse E est incomplète : elle laisse la vésicule lithiasique en place.

5. Hépatites B & C : CAT diagnostique et thérapeutique

Source : diaporama « Hépatites B & C — CAT Diagnostic & Thérapeutique ». Le cours est entièrement construit autour de deux cas cliniques ; les questions sont réparties tout au long du diaporama.

Cas clinique (I) — Patient de 58 ans

Patient âgé de 58 ans.

ATCD : infirmier à la retraite, père de 3 enfants ; DT2 ; chirurgie d'une hernie inguinale en 2021.

Ictère, asthénie majeure, nausées, vomissements, douleurs abdominales diffuses, évoluant depuis 3 semaines.

Bilan biologique : Hb 14 g/dl, GB 4 600/mm³, PQ 245 000/mm³, BT 189 mg/l, BC 120 mg/l, TGO 23 N, TGP 32 N, PAL 8 N, GGT 12 N ; glycémie 1,45 g/l, urée 0,64 g/l, créat 9 mg/l, TP 78 %.

Échographie abdominale : hypertrophie de la glande hépatique 14 cm, d'aspect homogène ; adénopathie hilaire hépatique d'allure inflammatoire ; épaississement de la paroi de la vésicule biliaire sans lithiase en son sein.

TLT : sans particularité.

Question 1 — Quel bilan demander ?

1. Biopsie hépatique
2. Sérologie VHA, VHB, VHC
3. Sérologie VHE, VHD
4. Scanner abdominal
5. Sérologie de la leptospirose

RÉPONSE RÉDIGÉE D'APRÈS LE COURS

2 (et 3) — les sérologies virales. C'est bien ce que fait le cours à la diapositive suivante, qui donne directement les résultats sérologiques. La biopsie hépatique et le scanner n'ont aucune place devant une hépatite aiguë cytolytique typique ; la leptospirose n'est évoquée que sur un contexte d'exposition (eaux souillées, rongeurs) absent ici.

Recommandations du cours de virologie associé : VHB → Ag HBs, Ac anti-HBc, Ac anti-HBs ; VHC → Ac anti-VHC ; VHD → IgG anti-VHD ; VHA/VHE → IgM et IgG.

Résultats : Ag HBs +, Ac anti-HBc IgM +, IgG +, Ag HBe +, Ac anti-HBe −, Ac anti-HBs − ; IgM VHA −, IgG VHA +, Ac anti-VHC −.

→ **Hépatite virale B aiguë.**

Évolution. Patient suivi en hôpital de jour : pas d'EH, persistance d'une cytolyse < 2 N, examen clinique sans particularité. **Perdu de vue 2 ans.**

Nouveau bilan : ALAT 3 N, ASAT 3,2 N, PAL 2 N, GGT 4 N, BT 15 mg/l.
Ag HBs +, Ac anti-HBc IgM −, IgG +, Ag HBe −, Ac anti-HBe −, Ac anti-HBs −.

Question 2 — Quels examens demander ?

1. PCR VHB
2. Échodoppler hépatique
3. FOGD à la recherche de varices
4. Fibroscan
5. Biopsie hépatique

RÉPONSE RÉDIGÉE D'APRÈS LE COURS

1, 2 et 4 (la FOGD et la PBH n'arrivent qu'en second temps, si fibrose avancée ou doute diagnostique).

*La diapositive suivante donne la règle générale : « **Que faire devant une sérologie VHB + > 6 mois ?** 1. Quantification de la charge virale (PCR) ; 2. Évaluation de la fibrose hépatique ; 3. Classer le patient selon le profil sérologique, biologique et morphologique. » L'évaluation de la fibrose repose sur les marqueurs non invasifs — sérologiques (AH, BT, A2MG, TP, haptoglobine, GGT) et physiques (Fibroscan) — la PBH restant le gold standard. La FOGD à la recherche de varices n'est justifiée qu'en cas de fibrose avancée (critères de Baveno VII).*

Question 3 — Faut-il traiter ? Oui / non ? Quel traitement ?

1. Lamivudine
2. **Ténofovir**
3. Adéfovir
4. Interféron pégylé
5. **Entécavir**

CORRIGÉ DU COURS

Oui, il faut traiter — et le traitement est le **Ténofovir (2)** ou l'**Entécavir (5)** (les deux items sont surlignés sur la diapositive).

Justification tirée du tableau ministériel reproduit dans le cours : hépatite chronique Ag HBe négatif avec ADN VHB > 2 000 UI/ml et ALAT > 2 LSN persistantes → traitement indiqué, histologie non requise. La lamivudine et l'adéfovir ont une barrière génétique faible (résistances) et ne sont plus recommandés en première ligne.
***Précautions avant analogues** (à connaître) : bilan bio/virologique (BH, GGT, PAL, TP, DFG, phosphorémie, ADN VHB, Ag HBs) ; adaptation des posologies d'ETV et de TDF si DFG < 50 ml/mn ; préférer l'ETV ou le TAF au TDF si âge > 60 ans, ostéoporose/ostéopénie, corticoïdes au long cours, DFG < 60, albuminurie > 30 mg/j, phosphatémie < 2,5 mg/dl, hémodialyse.*

COMPLÉMENT DU COURS — TYPES DE RÉPONSE VIROLOGIQUE SOUS ANALOGUES

- Non-réponse primaire : à 12 semaines, < 1 log de baisse.

- Réponse virologique partielle : à 24–48 semaines, > 1 log mais ADN-VHB toujours détectable.
- Réponse virologique : à 48 semaines, ADN-VHB négatif.
- Échappement sous traitement.

Cas clinique (II) — Patient de 32 ans

Patient âgé de 32 ans.

ATCD : IRC sur malformation des voies urinaires dans l'enfance ; hémodialyse depuis 15 ans ; HTA traitée.

Bilan du centre de dialyse : ALAT 2,8 N, ASAT 2 N ; FNS : anémie normochrome normocytaire 9 g/dl, GB N, PQ N ; TP 89 % ; DFG 10 ml/mn.

Échographie hépatique : normale.

Question — Quel bilan demander ?

CORRIGÉ DU COURS

- Sérologie virale A (IgM, IgG) / sérologie B complète / VHC
- Échodoppler
- **PCR VHC ++**

Résultats : sérologie VHC +, PCR 450 000 UI/ml.

*Pourquoi la PCR est indispensable ici : devant une sérologie VHC +, deux situations sont possibles — infection ancienne guérie (Ac +, ARN −, « cicatrice sérologique ») ou portage chronique (ARN +). Seule la PCR tranche. L'hémodialyse est le réservoir majeur du VHC en Algérie (prévalence rapportée dans le cours : **23,8 %** chez les hémodialysés, contre 0,16 % chez les donneurs de sang).*

COMPLÉMENT DU COURS — TRAITEMENT DU VHC CHEZ L'INSUFFISANT RÉNAL / HÉMODIALYSÉ

Traitement pangénotypique, sans interféron ni ribavirine :

- Sofosbuvir + daclatasvir : 12 semaines (24 semaines, ou 12 semaines + RBV, si cirrhose) ;
- Sofosbuvir + velpatasvir : 12 semaines.

En cas d'échec thérapeutique → déterminer le génotype : absence de cirrhose et génotype non 3 → SOF + velpatasvir + voxilaprévir 12 semaines ; cirrhose ou génotype 3 → SOF + velpatasvir + voxilaprévir + RBV 12 à 24 semaines.

Suivi : réponse virologique (ALAT/PCR à 3 et 6 mois) ; tolérance (rein, DMO, 1–2 ans) ; dépistage de l'HTP si fibrose avancée (Baveno VII : FS > 15 kPa et plaquettes < 150 000) annuel ; dépistage du CHC (AFP + échographie) tous les 6 mois si ≥ F3.

Les deux réflexes du cours : (1) toute sérologie VHC positive impose une **PCR ARN-VHC** ; (2) toute sérologie VHB positive persistant **plus de 6 mois** impose charge virale + évaluation de la fibrose + classement du patient selon son profil (infection chronique Ag

HBe+ / hépatite chronique Ag HBe+ / infection chronique Ag HBe− « portage inactif » / hépatite chronique Ag HBe− / infection résolue).

6. Ischémie mésentérique aiguë et infarctus entéro-mésentérique

Source : diaporama « Infarctus Entéro-Mésentérique 2026 » (Pr N. Annane). Le cours comporte une série de **5 QCM** (proposés en pré-test puis corrigés en fin de cours) et un **mini-cas clinique type concours**.

QCM 1

Concernant l'ischémie mésentérique aiguë :

A. Elle se manifeste toujours par une contracture abdominale.

B. Une douleur disproportionnée par rapport à l'examen est évocatrice.

C. Un lactate normal permet d'exclure le diagnostic.

D. L'angioscanner doit être réalisé précocement.

E. La mortalité reste élevée.



> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponses : B, D, E.**
> La contracture est généralement tardive. Le lactate peut être normal au début. L'angioscanner doit être réalisé dès la suspicion.

QCM 2

En faveur d'une embolie de l'AMS :

A. Fibrillation atriale.

B. Douleurs postprandiales anciennes obligatoires.

C. Début brutal.

D. Douleur abdominale intense.

E. Thrombose toujours située à l'origine de l'AMS.

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponses : A, C, D.**
> Les douleurs postprandiales anciennes orientent davantage vers une thrombose sur ischémie chronique. L'embolie se bloque souvent à distance de l'origine de l'AMS.

QCM 3

Concernant l'angioscanner :

A. Il doit comprendre une phase artérielle.

B. Une phase veineuse est utile.

C. Il doit être retardé jusqu'à la normalisation de la créatinine.

D. Le contraste oral est indispensable.

E. Il analyse les vaisseaux et la paroi intestinale.

CORRIGÉ DU COURS

Réponses : A, B, E.
L'insuffisance rénale ne doit pas retarder l'examen lorsque la suspicion est forte. Le contraste oral n'est pas nécessaire.

QCM 4

La thrombose veineuse mésentérique sans péritonite est principalement traitée par :

A. Anticoagulation curative.

B. Colectomie systématique.

C. Surveillance clinique rapprochée.

D. Antibiothérapie isolée.

E. Recherche d'un état prothrombotique.

CORRIGÉ DU COURS

Réponses : A, C, E.
La chirurgie est réservée à la péritonite, à la nécrose ou à une aggravation malgré le traitement.

QCM 5

Concernant le traitement chirurgical :

A. Tout intestin cyanique doit être immédiatement réséqué.

B. La revascularisation peut améliorer un intestin douteux.

C. Le second look peut éviter une résection excessive.

D. Une anastomose immédiate est obligatoire.

E. La résection doit préserver le maximum d'intestin viable.

CORRIGÉ DU COURS

Réponses : B, C, E.
Un intestin douteux peut récupérer après reperfusion. Chez un patient instable, l'intestin peut être laissé en discontinuité jusqu'au second look.

Mini-cas clinique type concours — « Raisonner mécanisme + urgence »

Homme de 78 ans, fibrillation atriale non anticoagulée. Douleur abdominale brutale, intense, depuis 4 heures. Abdomen souple, lactate normal. TA stable.

1. Quel mécanisme est le plus probable ?

RÉPONSE ATTENDUE

Embolie de l'AMS.

2. Quel examen demander en urgence ?

RÉPONSE ATTENDUE

Angioscanner artériel + veineux.

3. Le lactate normal modifie-t-il la décision ?

RÉPONSE ATTENDUE

Non : il n'élimine pas une IMA précoce.

4. Quelle équipe prévenir ?

RÉPONSE ATTENDUE

Chirurgien viscéral, chirurgien vasculaire, réanimateur, radiologue interventionnel.

Conclusion du cas : douleur brutale + FA = **embolie mésentérique jusqu'à preuve du contraire**.

SYNTHÈSE FINALE DU COURS — LES 8 MESSAGES À RÉCITER AU CONCOURS

- 1. Évoquer tôt chez un patient vasculaire ou en état de choc.
- 2. Douleur disproportionnée = signal d'alarme.
- 3. Lactate normal n'élimine pas.
- 4. Angioscanner artériel + veineux sans délai.
- 5. Péritonite = laparotomie urgente.
- 6. Forme artérielle = revascularisation urgente si possible.
- 7. Thrombose veineuse sans péritonite = héparine.
- 8. Intestin douteux = second look à 24–48 h.

Le bon réflexe : penser vite, scanner vite, revasculariser vite, réséquer juste.

7. Cancer du côlon

Source : diaporama « Cancer du Colon — Cas Clinique 2 ». Tout le cours est construit autour d'un **cas clinique unique (n° 01)**, déroulé en huit questions successives ; les réponses justes sont mises en gras sur la diapositive suivante.

Remarque : le diaporama donne 65 ans dans l'énoncé initial puis 62 ans dans les questions suivantes — les deux valeurs sont reproduites telles quelles.

Cas clinique n° 01 — Patient de 65 ans

> Patient âgé de 65 ans, sans antécédents personnels ou familiaux particuliers, se présente en consultation pour douleurs abdominales évoluant depuis 04 mois, avec une notion de constipation d'apparition récente et un amaigrissement chiffré à 06 kg en 02 mois.
>
> L'examen clinique ne retrouve rien de particulier en dehors d'une douleur à la palpation profonde du flanc gauche et de l'hypogastre.
>
> L'examen de la marge anale et le toucher rectal objectivent : un sphincter normotonique, pas de masse palpable, doigtier souillé de sang.

Question 1 — Devant cette symptomatologie, quels sont les diagnostics à évoquer devant ce tableau clinique ?

A. Diverticulose sigmoïdienne
B. MICI
C. Tuberculose intestinale
D. Cancer colique
E. Toutes ces réponses sont justes

> **CORRIGÉ DU COURS**
>
> **Réponse E** — toutes ces réponses sont justes.
>
> *Le tableau (douleurs du côlon gauche, trouble récent du transit, amaigrissement, rectorragies au TR) est celui d'une atteinte colique gauche : le cancer est le diagnostic à éliminer en priorité, mais diverticulose, MICI et tuberculose intestinale restent des diagnostics différentiels légitimes à ce stade.*

Question 2 — Devant ces données cliniques et anamnestiques, une forte probabilité de cancer colique est évoquée ; dans quelle classe de sujet à risque classez-vous votre patient ?

a. Risque faible
b. Risque intermédiaire (= risque *moyen* dans le reste du cours)
c. Risque élevé
d. Risque très élevé

> **CORRIGÉ DU COURS**

Sujet à risque moyen — la diapositive-réponse fait pointer une flèche vers la liste depuis un encadré rappelant les caractéristiques du patient : **homme**, **62 ans**, **aucun antécédent**. Ce sont exactement les critères du « sujet à risque moyen » défini juste après.

Les trois classes du cours :
***Risque moyen — 80 % des cas** : légère prédominance masculine, après 50 ans → dépistage organisé, recherche de sang dans les selles.*
***Risque élevé — 15 à 20 % des cas** : parents du 1er degré de sujets atteints de cancer colorectal, ATCD familiaux d'adénome colorectal, ATCD personnels de cancer colorectal, MICI (RCUH +++) → consultation gastro-entérologique et **coloscopie**.*
***Risque très élevé — 1 à 3 % des cas** : PAF, syndrome de Lynch → gastro-entérologue, consultation oncogénétique, chromocoloscopie.*
(Le diaporama numérote les items a, b, a, a ; la liste est reproduite ici avec une numérotation corrigée.)

Question 3 — Devant ce tableau clinique, quel examen demanderiez-vous ?

a. Échographie abdominale
b. Scanner abdominal avec injection de produit de contraste
c. Colonoscopie totale
d. Rectoscopie
e. IRM abdominale

RÉPONSE RÉDIGÉE D'APRÈS LE COURS

Colonoscopie totale — c'est l'examen que le cours enchaîne immédiatement (« Examens complémentaires : COLOSCOPIE TOTALE ») et que la suite du cas décrit comme ayant été réalisée.

*Le cours en détaille l'intérêt : visualiser le processus tumoral (tumeur bourgeonnante, plus ou moins ulcérée et nécrosée, parfois sténosante) ; préciser son siège par rapport à la marge anale ; réaliser des **biopsies** pour le diagnostic histologique (au minimum **10 à 15 biopsies**) ; explorer le côlon infra- et sus-tumoral et le rectum à la recherche d'une autre localisation ou de polypes associés, dont elle permet l'exérèse. Le **colo-scanner** (TDM abdomino-pelvienne après remplissage colique par ≈ 2 litres d'eau ou insufflation d'air) est réservé aux coloscopies incomplètes ou non réalisables.*
La diapositive dit « examen radiologique » alors que la réponse attendue est endoscopique : formulation du diaporama, reproduite telle quelle.

La colonoscopie réalisée retrouve un processus circonférentiel ulcéro-bourgeonnant du côlon gauche près de l'angle colique, non sténosant, avec la présence de 2 polypes infracentimétriques, l'un au niveau de l'angle colique gauche et l'autre au niveau du côlon transverse. Des biopsies ont été réalisées : l'étude anatomopathologique est en faveur d'un **adénocarcinome colique bien différencié du côlon gauche** ; les 2 polypes sont revenus en faveur d'un **adénome tubulo-villeux avec dysplasie de bas grade**.

Question 4 — Quel autre examen demanderiez-vous afin de renforcer votre hypothèse diagnostique ?

a. Les marqueurs tumoraux (ACE)

b. Scanner thoraco-abdomino-pelvien

c. IRM abdominale

d. PET scan

e. Toutes ces réponses sont fausses

CORRIGÉ DU COURS

Réponse e — toutes ces réponses sont fausses.

*Justification affichée sur la diapositive (recommandation ESMO) : « Diagnosis of the primary tumour. In the absence of a bowel obstruction or massive haemorrhage […] a total colonoscopy is recommended for diagnostic confirmation of colon cancer [I, A] ». Le **diagnostic est déjà fait** par la coloscopie et les biopsies ; les examens proposés relèvent du bilan d'**extension**, pas de la confirmation diagnostique. Piège classique : ne pas confondre diagnostic positif et bilan d'extension.*

Question 5 — Nous sommes devant un patient âgé de 62 ans, sans antécédents particuliers, présentant un adénocarcinome bien différencié du côlon gauche. Quelle sera la suite de votre prise en charge ?

a. Chirurgie d'emblée

b. Chimiothérapie néoadjuvante

c. Radiothérapie néoadjuvante

d. Bilan d'extension

e. Immunothérapie

CORRIGÉ DU COURS

Réponse d — bilan d'extension, conformément à la citation ESMO reproduite sur la diapositive : « *Assessment of patient baseline status and characteristics. After colonic tumour diagnosis, clinical examination and laboratory tests must be carried out to provide a correct assessment of patient status and characteristics before deciding the definitive treatment approach [II, A]* ».

***Bilan de la maladie** selon le cours — recherche d'extension **locorégionale** et à **distance** :*
*• **Clinique** : masse palpable, hépato-splénomégalie, ascite, adénopathies, ganglion de Troisier, nodules de carcinose au toucher rectal.*
*• **Biologique** : marqueurs tumoraux — **ACE** (très élevé, > 20 ng/ml = maladie évolutive/ métastatique probable) et **CA 19-9** ; leur intérêt principal est le **suivi post-opératoire** et la recherche de récidive.*
*• **Radiologique** : **scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection** (grade B), à la recherch métastases viscérales (foie, poumons, surrénales), d'implants péritonéaux et de leurs équivalents (métastases ovariennes), d'adénopathies à distance et de l'extension locale. En cas d'allergie à l'iode ou d'insuffisance rénale : IRM hépatique injectée au gadolinium + scanner thoracique sans injection.*

Question 6 — Il s'agit d'un patient âgé de 62 ans sans antécédents particuliers, avec un adénocarcinome bien différencié du côlon gauche classé cT3N+M0, présentant par ailleurs deux polypes coliques non réséqués dont l'étude anatomopathologique retrouve une dysplasie de bas grade. Quel sera votre projet thérapeutique ?

a. Chirurgie carcinologique d'emblée

b. Résection endoscopique des polypes suivie d'une chirurgie carcinologique seule

c. Radiothérapie néoadjuvante

d. Chimiothérapie néoadjuvante

e. Résection endoscopique des polypes suivie d'une chirurgie carcinologique avec une éventuelle chimiothérapie adjuvante

CORRIGÉ DU COURS

Réponse e (référence ESGE affichée sur la diapositive).

*Trois idées à retenir : les polypes à distance sont traités par **résection endoscopique** et non par une colectomie élargie ; il n'y a **pas de traitement néoadjuvant** dans le cancer du **côlon** (contrairement au cancer du rectum, où la radiochimiothérapie néoadjuvante a sa place) ; la chimiothérapie adjuvante est décidée **après** la chirurgie, sur les données anatomopathologiques définitives — d'où le terme « éventuelle ».*

Question 7 — Sachant qu'une résection endoscopique des deux polypes a été faite avec succès, montrant une dysplasie de bas grade, quel geste chirurgical préconisez-vous ?

a. Une hémicolectomie gauche avec curage mésentérique inférieur

b. Une colectomie subtotale avec curage mésentérique inférieur et supérieur

c. Une colostomie de proche amont

d. Une résection segmentaire gauche avec curage mésentérique inférieur

e. Une coloproctectomie avec curage mésentérique inférieur

CORRIGÉ DU COURS

Réponse d — résection segmentaire gauche (haute) avec curage mésentérique inférieur.

*Le cours oppose les deux gestes : l'**hémicolectomie gauche** (résection depuis le bord gauche du transverse jusqu'à la charnière recto-sigmoïdienne, AMI liée à son origine, anastomose transverso-rectale) est « de moins en moins utilisée » ; la **résection segmentaire gauche haute** lie à son origine l'artère colique supérieure gauche, avec anastomose transverso-sigmoïdienne.*
***Principes carcinologiques** à connaître : marges longitudinales d'au moins **5 cm** de part et d'autre (10 cm si tumeur infiltrante) ; curage ganglionnaire satisfaisant = au moins **12 ganglions** (recommandations américaines : 12 puis 15 ; consensus français 1998 : au moins 8 ; Thésaurus de cancérologie digestive 2006 : au moins 12) ; résection monobloc des organes envahis ; la seule contre-indication à la résection complète est l'envahissement vasculaire artériel ou veineux.*

Question 8 — Une résection segmentaire haute a été réalisée avec curage mésentérique inférieur. L'étude anatomopathologique est revenue en faveur d'un adénocarcinome colique bien différencié classé pT3N2M0. Quelle sera votre attitude ?

a. Surveillance seule

b. 12 séances de chimiothérapie adjuvante

c. Radiothérapie adjuvante

d. Immunothérapie

e. Chimiothérapie adjuvante et surveillance

CORRIGÉ DU COURS

Réponse e — chimiothérapie adjuvante et surveillance.

*Schéma affiché sur la diapositive-réponse : selon le stade → non métastatique → **stade III (N+)** → **chirurgie + chimiothérapie adjuvante**. La surveillance fait partie intégrante de la prise en charge (le cours consacre une diapositive au suivi, avec une surveillance rapprochée « up to 3 years after surgery », l'ACE servant au dépistage de la récidive). La radiothérapie n'a pas de place dans le cancer du côlon et l'immunothérapie est réservée aux tumeurs MSI-H/dMMR métastatiques.*

Fil conducteur du cas : tableau colique gauche → **coloscopie totale + biopsies** (diagnostic) → **bilan d'extension** (TDM TAP + ACE) → classification cTNM → **chirurgie carcinologique** adaptée au siège, marges ≥ 5 cm et ≥ 12 ganglions → pTNM → **chimiothérapie adjuvante si stade III** → surveillance.

8. Lithiase biliaire et ses complications

Source : document de synthèse « Lithiase biliaire et ses complications ». Le document se termine par une rubrique « **Exemples** » comportant deux vignettes cliniques avec leur attitude thérapeutique.

Exemple clinique 1 — Femme de 75 ans

> Patiente âgée de 75 ans, cholécystectomisée, admise dans le cadre de l'urgence pour une **angiocholite aiguë sur macrolithiase de la VBP**, classée **grade II selon les critères de Tokyo**.

Question — Quelle attitude thérapeutique ?

CORRIGÉ DU COURS

Antibiothérapie + CPRE dans les 24–72 h.

*Grade II (angiocholite modérée) = drainage biliaire endoscopique **précoce mais non immédiat**, après antibiothérapie. Le grade III (défaillance d'organe) impose la réanimation et un drainage **en urgence**.*

Exemple clinique 2 — Femme de 50 ans

> Patiente âgée de 50 ans, consulte pour des coliques hépatiques. À l'échographie : vésicule à paroi fine, microlithiasique, et une **VBP à 9 mm** siège de **2 microlithiases de 3 à 5 mm**.

Question — Quelle attitude thérapeutique ?

CORRIGÉ DU COURS

Sphinctérotomie endoscopique suivie d'une cholécystectomie par voie cœlioscopique.

On désobstrue d'abord la voie biliaire principale, puis on traite le réservoir (la vésicule) pour éviter la récidive — c'est la même logique que dans le dossier de pancréatite aiguë biliaire (section 4, question 8).

RAPPELS DU DOCUMENT — LES AFFIRMATIONS À CONNAÎTRE

Lithiase vésiculaire (LV)

• Souvent asymptomatique ; révélée par des douleurs de type colique hépatique.
• La LV asymptomatique **n'est pas** une indication à la cholécystectomie — « tant que c'est asymptomatique, on ne touche pas », y compris devant une macrolithiase de découverte fortuite chez la femme.
• L'**échographie** est l'examen de première intention.
• La **colique hépatique** : douleur liée à la mise en tension brutale des voies biliaires ;

siège le plus souvent dans l'HCD ; irradiation fréquente vers l'épaule droite ; une douleur épigastrique de survenue brutale sans défense péritonéale peut la faire évoquer en premier lieu.

Cholécystite aiguë — complication la plus fréquente de la LV ; traitement : antibiothérapie + cholécystectomie.
• Diagnostic évoqué devant : hyperleucocytose ou élévation de la CRP ; fièvre et douleur d'apparition brutale de l'HCD ; épaississement de la paroi vésiculaire (> 4 mm) + image de calcul à l'échographie (hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur).
• **L'ictère est un signe de chronicité** : la cholécystite devrait être très avancée pour causer une cholestase — donc pas d'ictère dans la cholécystite simple.
• Critères de **gravité** : hyperleucocytose > 18 000 ; masse palpable de l'HCD ; insuffisance rénale ; terrain fragile d'immunodépression. *(La fièvre est un signe d'existence, pas de gravité.)*
• Complications : angiocholite, pancréatite aiguë, péritonite aiguë, occlusion intestinale aiguë, abcès hépatique.

Angiocholite aiguë (AA) — complication liée à un obstacle sur la VBP ; **urgence médico-chirurgicale**.
• **Triade de Charcot** : douleur → fièvre → ictère, dans un délai de **48 h**.
• Diagnostic fortement évoqué devant : fièvre + obstacle visible + **dilatation de la VBP > 10 mm**.
• L'élévation de la **créatinine sérique** témoigne de la gravité (IRA).
• Complications aiguës : choc septique + insuffisance rénale ; abcès hépatique.
• Les **hémocultures** sont souvent positives à BGN ; la désobstruction de la VBP par sphinctérotomie endoscopique est une urgence.
• Étiologies imposant un drainage biliaire en urgence : lithiase de la VBP, lésions iatrogènes, cholangiocarcinome de type I de Bismuth-Corlette, ampullome vatérien, tumeur de la tête du pancréas ou des voies biliaires.
• Traitement de 1re intention devant une **angiocholite grave** : réanimation hydro-électrolytique + antibiothérapie à large spectre + **CPRE avec sphinctérotomie** (« la meilleure arme thérapeutique »).

Indications de la cholécystectomie
• LV **symptomatique** quelle que soit la taille des calculs ; cholécystite aiguë ; polype d'au moins **7 mm** appendu à la paroi vésiculaire ; LV associée à une LVBP ; macrolithiase vésiculaire compliquée de pancréatite aiguë.
• **Cholécystectomie prophylactique** : polype intravésiculaire de plus de **1 cm** ; augmentation de taille d'un polype au cours du suivi ; anomalies de la jonction bilio-pancréatique ; vésicule scléro-atrophique calcifiée (**vésicule porcelaine** = indication chirurgicale).